République du Congo

Unité-Travail-Progrès

Ministère de la Santé et de la Population

Unité de Coordination des Programmes et Projets

Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale

GUIDE DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DE L'INSUFFISANCE RENALE EN REPUBLIQUE DU CONGO

Table des matières

Listes des abréviations 1

Glossaire 3

Préface 6

Introduction 7

1. Objectifs 9

1.1. Objectif général 9

1.2. Objectifs spécifiques 9

2. Cadre institutionnel 9

3. Système d'information sanitaire 10

Partie I : Opérationnalisation de la surveillance (modèle SIMR) 12

I.1. Détection et Enregistrement des Cas 12

I.1.1. Modes de surveillance 12

I.1.2. Identification des cas selon les niveaux de soins 12

I.1.3. Outils de collecte primaire 14

I.1.4. Définitions de Cas 14

I.2. Notification, Flux de Données et Éthique 16

I.2.1. Circuit de transmission de l'information (La chaîne de remontée) 16

I.2.2. Éthique et Confidentialité 17

I.3. Analyse et Interprétation 18

Partie II : Gestion clinique et riposte 20

Partie III : Suivi, évaluation et qualité 21

III.1. Monitoring de la Surveillance 21

III.1.1. Indicateurs de performance du système de surveillance 21

III.1.2. Supervision formative des agents de santé 22

III.2. Gestion de la Qualité des Données 22

III.2.1. Procédures de validation et de nettoyage des bases de données. 22

III.2.2. Retour d'information vers les districts et les structures de soins. 23

III.3. Indicateurs 24

Conclusion 30

Références 31

V. Annexes techniques 33

Listes des abréviations

CHU	Centre hospitalier universitaire
CSI	Centre de santé intégré
DDSSSa	Direction départementale des soins et services de santé
DFG	Débit de filtration glomérulaire
DHIS2	District health information software
DISER	Direction de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche
FFOM	Force, faiblesse, opportunité et menace
FOSA	Formation sanitaire
HG	Hôpital général
HRD	Hôpital de référence de district
HTA	Hypertension artérielle
IR	Insuffisance rénale
IRA	Insuffisance rénale aigue
IRC	Insuffisance rénale chronique
IRC-T	Insuffisance rénale chronique phase terminale
IRM	Imagerie à résonance magnétique
ISN	International society of nephrology
MNT	Maladie non transmissible
OMS	Organisation mondiale de la santé
PAD	Pression arterielle diastolique
PAS	Pression arterielle systolique
PNLIR	Programme national de lutte contre l'insuffisance rénale
PSN	Plan stratégique national
SIS	Système d'information sanitaire
SIMR	Surveillance intégrée de la maladie et de la riposte
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

Listes des tableaux

Tableau I : Détection des cas selon le niveau de la pyramide des soins..... 13
Tableau II : Définition des cas..... 14
Tableau III : Notification des cas selon les structures des soins de santé 17
Tableau IV : Méthodes et outils d'analyse 19
Tableau V : Indicateurs..... 24

Glossaire

Agent de santé communautaire (ASC) : Membre de la communauté formé pour fournir des services de promotion, de prévention et d'appui aux soins de santé. (1)

Bandelette urinaire : Dispositif diagnostique permettant la détection semi-quantitative de substances présentes dans l'urine. (2)

Cas confirmé : Cas répondant à la définition de cas et confirmé par des examens de laboratoire spécifiques. (3)

Cas présumé : Cas présentant des éléments cliniques et/ou épidémiologiques fortement évocateurs d'une maladie sans confirmation biologique. (3)

Cas suspect : Personne présentant des signes ou symptômes compatibles avec une maladie donnée selon une définition standardisée. (3)

Collecte de données : Processus de recueil systématique des informations nécessaires à la surveillance, à la gestion et à l'évaluation des programmes de santé. (4)

Complétude des rapports : Proportion des rapports attendus effectivement reçus et correctement renseignés au cours d'une période donnée. (5)

Créatinine : Produit du métabolisme musculaire éliminé principalement par filtration glomérulaire. (6)

Créatininémie : Concentration de créatinine mesurée dans le sérum ou le plasma sanguin. (6)

Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) : Volume de plasma filtré par les glomérules rénaux par unité de temps, exprimé en ml/min/1,73 m². (7)

Dépistage précoce : Identification d'une maladie ou d'un facteur de risque avant l'apparition des manifestations cliniques. (8)

DHIS2 (District Health Information Software 2) : Plateforme numérique de collecte, de gestion, d'analyse et de diffusion des données sanitaires. (9)

Diabète sucré : Groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie (≥ **1,26 g/L** à jeun et ≥ **2 g/L**) chronique résultant d'un défaut de sécrétion ou d'action de l'insuline. (10)

Dépistage tardif : Diagnostic établi à un stade avancé de la maladie après l'apparition des manifestations cliniques ou des complications. (8)

Facteur de risque : Caractéristique, condition ou exposition associée à une augmentation de la probabilité de survenue d'une maladie ou d'un événement de santé. (11)

Formation sanitaire (FOSA) : Structure offrant des prestations de soins ou de services de santé à la population. (12)

Hématurie : Présence anormale d'érythrocytes dans les urines. (13)

Hémodialyse : Technique d'épuration extrarénale utilisant une membrane semi-perméable pour éliminer les déchets et l'excès de liquide du sang. (14)

Hémodialyse chronique : Traitement de suppléance rénale par hémodialyse réalisé de façon régulière et prolongée chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. (15)

Hypertension artérielle résistante : Hypertension artérielle non contrôlée malgré l'utilisation concomitante de trois antihypertenseurs de classes différentes, dont un diurétique, à doses optimales, ou nécessitant au moins quatre antihypertenseurs pour atteindre les objectifs tensionnels. (17)

Hypertension artérielle sévère : Pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg et/ou pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg. (16)

IRA

Insuffisance rénale chronique (IRC) : Anomalie de la structure ou de la fonction rénale présente depuis au moins trois mois avec des implications pour la santé. (7)

Maladies non transmissibles (MNT) : Maladies de longue durée qui ne se transmettent pas directement d'une personne à une autre. (18)

Maladie rénale chronique (MRC) : Anomalie de la structure ou de la fonction rénale persistant plus de trois mois et ayant des conséquences sur la santé. (7)

Perdu de vue : Patient dont le suivi médical a été interrompu pendant une période définie sans information documentée sur son devenir. (19)

Dans le cadre de l'insuffisance rénale, on distingue deux niveaux : **pour les patients sous dialyse, t**oute absence de séance de traitement pendant une période d'un **(01) mois**. **Pour les patients non dialysés, t**oute absence de suivi médical pendant une période de trois **(03) mois**.

Prévention : Ensemble des mesures visant à éviter la survenue, la progression ou les complications d'une maladie ou d'un évènement. (20)

Prise en charge : Ensemble des interventions médicales, psychosociales et organisationnelles destinées à répondre aux besoins d'un patient. (21)

Promptitude des rapports : Proportion des rapports reçus dans les délais prescrits. (5)

Protéinurie : Présence anormale de protéines dans les urines. (7)

Riposte : Ensemble des mesures mises en œuvre pour prévenir, contrôler ou limiter l'impact d'un événement de santé publique. (22)

Surveillance épidémiologique : Collecte, analyse, interprétation et diffusion continues des données de santé nécessaires à l'action de santé publique. (24)

Surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) : Stratégie de surveillance visant à détecter, notifier, analyser et répondre aux menaces prioritaires pour la santé publique. (23)

Système d'information sanitaire (SIS) : Ensemble des ressources, processus et outils permettant la collecte, le traitement, l'analyse et l'utilisation des données sanitaires. (25)

Préface

Le renforcement de notre système de santé face à la montée des maladies non-transmissibles (MNT) constitue une priorité majeure pour le Gouvernement de la République du Congo. Parmi ces pathologies, L'insuffisance rénale occupe une place particulièrement préoccupante en raison de son évolution silencieuse, ses conséquences dévastatrices et son impact socioéconomique considérable sur notre population.

Pendant de nombreuses années, l'absence de données épidémiologique fiables a entravé notre capacité à anticiper et à répondre efficacement à ce fardeau. L'insuffisance rénale ne doit plus être perçus comme une fatalité découverte au stade terminal, mais comme une pathologie pouvant être identifié et surveillée pour une prise en charge précoce.

Ce présent Guide de Surveillance Epidémiologique de l'Insuffisance Rénale est un document qui marque une étape décisive dans le renforcement de notre système de l'information sanitaire. En intégrant la surveillance rénale dans la plateforme DHIS2 et en simplifiant les définitions de cas au niveau communautaire jusqu'aux centres spécialisés, nous nous donnons les moyens d'une action publique précise et éclairée.

J'exhorte vivement, l'ensemble des acteurs du système de santé à s'approprier rigoureusement cet outil. L'efficacité de notre riposte dépendra de la régularité des notifications, de la fiabilité de données et la qualité de l'analyse.

Je tiens à saluer l'engagement du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR) et de nos partenaires pour l'élaboration de ce cadre de référence. C'est ensemble, par une information fiable et une action rapide, que nous réduirons le fardeau des maladies rénales dans notre pays.

Ministre de la Santé et de la Population

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE
REPUBLIQUE DU CONGO

Pr. **Jean-Rosaire IBARA**

Introduction

L'insuffisance rénale constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La maladie rénale chronique (MRC) touche plus de 850millions de personnes dans le monde (26). Chaque année, les maladies rénales sont responsables d'environ 5 millions de décès (2è), tandis que leur prévalence continue d'augmenter sous l'effet de la progression du diabète sucré, de l'hypertension artérielle et d'autres facteurs de risque liés aux changements des modes de vie et aux transitions démographiques et épidémiologiques **(27).**

En Afrique, cette problématique est caractérisée par un double fardeau épidémiologique. Aux maladies infectieuses et parasitaires, telles que l'infection à VIH et le paludisme, qui sont à l'origine de nombreux cas d'insuffisance rénale aiguë (IRA), s'ajoute l'augmentation rapide des maladies non transmissibles (MNT). L'Afrique subsaharienne présente les niveaux d'accès aux soins néphrologiques parmi les plus faibles au monde. La MRC y est souvent diagnostiquée à un stade avancé, voire terminal, chez des sujets jeunes en pleine activité socio-économique, contrairement aux pays à revenu élevé où elle touche principalement les personnes âgées. Les capacités de prévention, de dépistage précoce, de prise en charge et de surveillance demeurent insuffisantes dans la plupart des pays de la région (28).

En république du Congo elle constitue une menace sanitaire majeur, les données existante au sein des différents services de néphrologies notamment celui du CHU de Brazzaville sont alarmantes : elle représente plus de 50 % des hospitalisations(29) en néphrologie et frappe une population jeune (moyenne d'âge de 51 ans), trop souvent diagnostiquée à des stades terminaux. Plusieurs facteurs contribuent à cela, ils sont dominés par le diabète (23,3 % à Brazzaville) et l'hypertension artérielle (21,8 %), l'obésité, le tabagisme, la consommation d'alcool, l'automédication et le recours à la phytothérapie, participent également. La faiblesse des mécanismes de prévention, de détection précoce et de remontée des données sanitaires contribue à accentuer ce problème. Cette situation est aggravée par un système de notification peu intégré qui limite la capacité du Ministère de la Santé à disposer de données fiables pour orienter efficacement les politiques et interventions de santé publique.

Face à ces enjeux, le présent **Guide de Surveillance Épidémiologique de l'Insuffisance Rénale** a été élaboré sous l'égide du Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR). Il vise à fournir un cadre harmonisé pour la détection, la notification, l'analyse, l'interprétation et le suivi des cas d'insuffisance rénale à tous les niveaux de la

pyramide sanitaire. Le guide décrit les procédures standardisées de surveillance, les circuits de collecte et de transmission des données à travers le système DHIS2, les indicateurs de suivi et d'évaluation, ainsi que les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués. Il constitue un outil de référence destiné aux décideurs, gestionnaires de programmes, épidémiologistes, cliniciens et autres professionnels de santé afin de renforcer la production et l'utilisation des données pour une prise de décision éclairée et une amélioration durable de la prévention et de la prise en charge de l'insuffisance rénale en République du Congo.

1. Objectifs

1.1.Objectif général

Renforcer le système de surveillance épidémiologique de l'insuffisance rénale en République du Congo.

1.2. Objectifs spécifiques

- Fournir un cadre technique pour le renforcement des capacités et compétences du personnel de santé impliqué dans la surveillance de l'insuffisance rénale ;
- Standardiser les procédures de collecte, d'enregistrement et de notification des données sur l'insuffisance rénale dans les formations sanitaires ;
- Définir les rôles, responsabilités et le circuit de transmission des données de l'IR entre les différents niveaux du système de santé ;
- Fournir aux acteurs de santé les orientations nécessaires pour l'analyse, l'interprétation et l'utilisation des données de surveillance de l'insuffisance rénale ;
- Préciser les modalités de diffusion et de rétro-information des données afin de soutenir la prise de décision et les actions de santé publique.

2. Cadre institutionnel

Le Programme National de Lutte contre l'Insuffisance Rénale (PNLIR), créé par le décret n°2019-225 du 13 août 2019 et placé sous l'autorité du Ministère de la Santé et de la Population, constitue le pilier institutionnel de cette initiative.

Conformément à ses missions légales, le PNLIR est chargé de collecter les données épidémiologiques, de coordonner la lutte contre la maladie, d'organiser les activités préventives et d'élaborer les normes de prise en charge et de notification. Au sein de sa structure, le Département du Dépistage et de la Surveillance épidémiologique est

spécifiquement responsable de la mise en œuvre du système de surveillance. Cette démarche s'inscrit directement dans le Plan Stratégique National 2025-2029, dont le Programme 4 fixe des objectifs clairs, notamment la mise à disposition d'outils de collecte paramétrés dans le DHIS2 et le développement d'un système résilient de surveillance des cas et des décès.

En tant qu'organe technique central, le PNLIR assure la coordination nationale de la surveillance en travaillant en étroite collaboration avec plusieurs acteurs clés. Il s'appuie sur la Direction de l'Information Sanitaire, de l'Évaluation et de la Recherche (DISER) pour l'intégration des données dans la plateforme DHIS2, ainsi que sur les Directions Départementales des Soins et Services de Santé (DDSSSa) pour l'exécution opérationnelle. Sur le terrain, les districts sanitaires et les diverses formations sanitaires, assurent la collecte et la notification quotidienne des informations. Enfin, ce dispositif bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires, garantissant ainsi la pérennité et l'efficacité de la surveillance épidémiologique en République du Congo.

3. Système d'information sanitaire

En République du Congo, le système d'information sanitaire (SIS) repose sur la plateforme **DHIS2**, déployée et coordonnée par la DISER. Ce système permet la collecte, la validation, l'analyse et la diffusion des données de santé issues de l'ensemble des formations sanitaires. Les données sont produites de manière continue, agrégées mensuellement et transmises selon un circuit hiérarchique et standardisé : du niveau périphérique (communauté, CSI) jusqu'au niveau central (DISER, programmes nationaux).

- **La Communauté :** assure l'identification des événements de santé (cas suspects, décès communautaires, comportements à risque) et transmet ces informations au CSI de leur aire de santé.
- **Centre de santé intégré :** assure la tenue des registres de consultation et de soins, la production et la transmission des rapports DHIS2 mensuels agrégés au District Sanitaire.
- **District sanitaire :** vérifie la complétude et la cohérence des données, les renseigne dans le DHIS2 et assure la supervision formative des CSI.
- **Direction départementale des soins et services de santé :** assure la consolidation des données des districts de son département, analyse les tendances, détecte les anomalies et transmet les bases départementales au niveau national.

- **DISER/Programmes de santé :** la DISER est responsable de l'administration centrale du DHIS2, les programmes de santé utilisent ces données pour le pilotage stratégique, la planification, le suivi-évaluation et les alertes épidémiologiques.

Partie I : Opérationnalisation de la surveillance (modèle SIMR)

I.1. Détection et Enregistrement des Cas

C'est l'identification de tout cas suspect d'insuffisance rénale à l'aide de la définition standardisée des cas. Celle-ci peut se faire dans les formations sanitaires publiques et privées par les prestataires de services de santé ou dans la communauté par l'intermédiaire des agents de santé communautaire. Tout cas suspect détecté par l'agent de santé communautaire sera référé au niveau du CSI. Après l'identification de tous les cas suspects, les données doivent être consignées dans un registre. S'il s'agit d'une formation sanitaire où le plateau technique ne permet pas de diagnostiquer l'insuffisance rénale, orienter les patients vers une formation qui le fera.

I.1.1. Modes de surveillance

- **Surveillance passive** : notification via les rapports de routine des formations sanitaires (CSI, Hôpitaux).
- **Surveillance active** : enquêtes ciblées, revue de dossiers pour les cas complexes et recherche de cas au niveau communautaire, campagne de dépistage.

I.1.2. Identification des cas selon les niveaux de soins

- **Niveau Communautaire :** identification des facteurs de risque par les agents de santé communautaires (référence vers le CSI).
- **Niveau des Centres de Santé Intégrés :** dépistage initial, identification des comorbidités et premiers signes d'insuffisance rénale.
- **Niveau des Centres Spécialisées/Hôpitaux :** diagnostic clinique confirmé par les médecins, néphrologues et infirmiers spécialisés**.**

Tableau I : Détection des cas selon le niveau de la pyramide des soins.

Niveau de structure	Type d'activité	IRA	IRC	Outils disponibles	Personnel responsable
Communauté	Sensibilisation/Orientation de cas suspects vers les CSI	Repérage des cas suspects		Fiche de référence / orientation, boite à image.	Agent de santé communautaire
Centres de santé	Dépistage précoce / Orientation vers les HRD	Repérage des cas suspects Dépistage des groupes à risque		Tensiomètre, bandelette urinaire, balance, toise, glucomètre, fiche de référence / orientation.	Prestataires des soins,
Hôpital de Référence de district(base)	Dépistage + diagnostic initial+ Confirmation + prise en charge/Orientation vers les HG	Repérage des cas suspects et confirmation des cas		Bandelette urinaire, Automate de biochimie, échographie Dossier médical.	Assistant sanitaire ; Médecin généraliste/ interniste, néphrologue
Hôpital général /régional/Centres spécialisés	Diagnostic approfondi + traitement spécialisé	Confirmation et prise en charge spécialisée des cas	Confirmation et prise en charge spécialisée des cas	Automates de biochimie et d'histoimmunologie Echographie / Scanner / IRM Générateur d'hémodialyse	Néphrologue Infirmiers spécialisés en dialyse Néphropédiatre

I.1.3. Outils de collecte primaire

Il s'agit des registres de consultation (CSI/Hôpitaux), des fiches de notification individuelle et l'utilisation du thésaurus de néphrologie**.**

I.1.4. Définitions de Cas

Tableau II : Définition des cas

Maladies rénales	Définitions des cas
Niveau communautaire : Insuffisance rénale	Cas suspect : toute personne présentant un ou plusieurs signes ou symptômes suivants : • Urine mousseuse ; • Modification de la couleur et de la quantité des urines ; • Œdèmes (Gonflement) ; • Tension artérielle élevée/Glycémie élevée.
Formations sanitaires (FOSA) : **Insuffisance rénale aigue**	**Cas suspect** : toute personne présentant au moins l'un des facteurs de risque et/ou au moins un signe ou symptômes suivants, sans confirmation biologique : • **Facteurs de risque :** o Déshydratation o Grossesse compliquée o Fièvre o Consommation des substances néphrotoxiques (anti-inflammatoires, antibiotiques, tisanes) ; o Automédication **;** o HTA. • **Signes cliniques :** o Oligurie brutale (réduction de la quantité d'urine) o Œdèmes ; o Asthénie ;
	Cas présumé : tout cas suspect ou non présentant une anomalie rénale détectée avec les tests préliminaires, mais sans confirmation : • Critères biologiques : o Albuminurie positive ; o Hématurie positive ; o Glucosurie positive.

Maladies rénales	Définitions des cas
	Cas confirmé : toute personne présentant une Oligurie et/ou Anurie persistante supérieur à 24 h ; Et une Créatinine élevée.
Formations sanitaires (FOSA) : Insuffisance rénale chronique	**Cas suspect :** toute personne présentant un facteur de risque et/ou un des signes ou symptômes suivants, sans confirmation biologique : • Facteurs de risque : o Hypertension artérielle ; o Diabète ; o Antécédent familiale de la maladie rénale ; o VIH ; o Obésité ; o Tabagisme ; o Maladies inflammatoires ou infectieuses chroniques ; o Age > 60 ans ; o Consommation des substances néphrotoxiques (anti-inflammatoires, antibiotique, tisanes) o Automédication ; o HTA • Signes cliniques : o Œdèmes ; o Nycturie (plusieurs mictions la nuit) ; o Asthénie chronique ; o Anorexie o Urine mousseuse ; o Pâleur ;
	Cas présumé : tout cas suspect ou non présentant une anomalie rénale détectée une seule fois, mais sans confirmation : • Critères biologiques (1 seul résultat) : o Protéinurie positive ; o Albuminurie positive ; o Hématurie persistante.

Maladies rénales	Définitions des cas
	Cas confirmé : toute personne présentant depuis plus de 3 mois au moins un des critères suivants : • Critère 1 : ○ DFG < 60/ml/min/1,73m2. • Critères 2 : marqueurs de lésions rénales : ○ Albuminurie ≥ 30 mg/g ; ○ Rapport albumine/créatinine ≥ 30 mg/g ; ○ Protéinurie persistante ; ○ Hématurie d'origine rénale ; ○ Anomalie structurelle à l'échographie.

I.2. Notification, Flux de Données et Éthique

Elle consiste à renseigner tous les cas (suspects et confirmés) d'insuffisance rénale pour que des mesures soient prises. Les responsables des formations sanitaires (publiques et privées) et les agents de santé communautaire doivent notifier les cas d'insuffisance rénale répondant à la définition de cas à travers les supports existants (fiche de notification, rapport).

I.2.1. Circuit de transmission de l'information (La chaîne de remontée)

L'information sanitaire est transmise mensuellement en respectant la pyramide sanitaire. Dans la communauté, les agents communautaires sont chargés de transmettre les informations (fiche de notification des cas suspects) au CSI de leur aire de santé. Les centres de santé ont pour mission de tenir les registres et remonter les informations (rapports) vers le DS. Les DS quant à eux, compilent les informations des centres de santé, renseignent les données dans le DHIS2 et transmettent des rapports à la direction départementale des soins et services de santé (DDSSSa). Les DDSSSa compilent et analysent les informations des DS et remontent les informations au PNLIR/DGSSSa.

I.2.2. Éthique et Confidentialité

La confidentialité et l'anonymat des patients doivent être strictement respectés. Les données collectées seront stockées sur des supports sécurisés, anonymes lors de la compilation et rendues accessibles uniquement aux personnes autorisées (agents de santé, gestionnaire des données).

Tableau III : Notification des cas selon les structures des soins de santé

Structures	Responsables	Outils
Communauté	Agents de santé communautaire	Fiche de notification de l'agent de santé communautaire
Centres de santé intégrés (CSI)	Chefs de centres, chefs d'unités ou personne désignée	Registres de consultation, fiches des patients, rapports DHIS2
Hôpitaux de référence	Gestionnaire des données, les majors, chefs de service ou personne désignée	Dossiers médicaux des patients, fiches des patients, registres des patients, DHIS2, Rapports
Districts sanitaires	Gestionnaire des donnés	DHIS2
Hôpital général / régional/Centres spécialisés	Major, infirmiers ou personne désignée	Dossiers médicaux des patients, fiches des patients, registres des patients

I.3. Analyse et Interprétation

La préparation et l'analyse des données constituent un important volet de la surveillance. Il ne suffit pas de recueillir, d'enregistrer et de rapporter des chiffres sur la maladie, les décès et les handicaps dans la zone desservie, il faut aussi les analyser à chaque niveau où ils ont été recueillis.

C'est cette analyse qui apporte l'information dont on se servira pour prendre des mesures de santé publique pertinentes, appropriées et en temps utile. Ainsi, l'analyse des données de la surveillance permet :

- D'observer les tendances dans le temps et les émergences ou de profils de morbidité inhabituels
- D'identifier les zones à plus haut risque (prévalence élevée)
- De déterminer les cas de maladie rénale et autres éléments le constituant en fonction des variables individuelles, telles que l'âge, le sexe ou la profession.

L'analyse de données doit respecter les étapes suivantes :

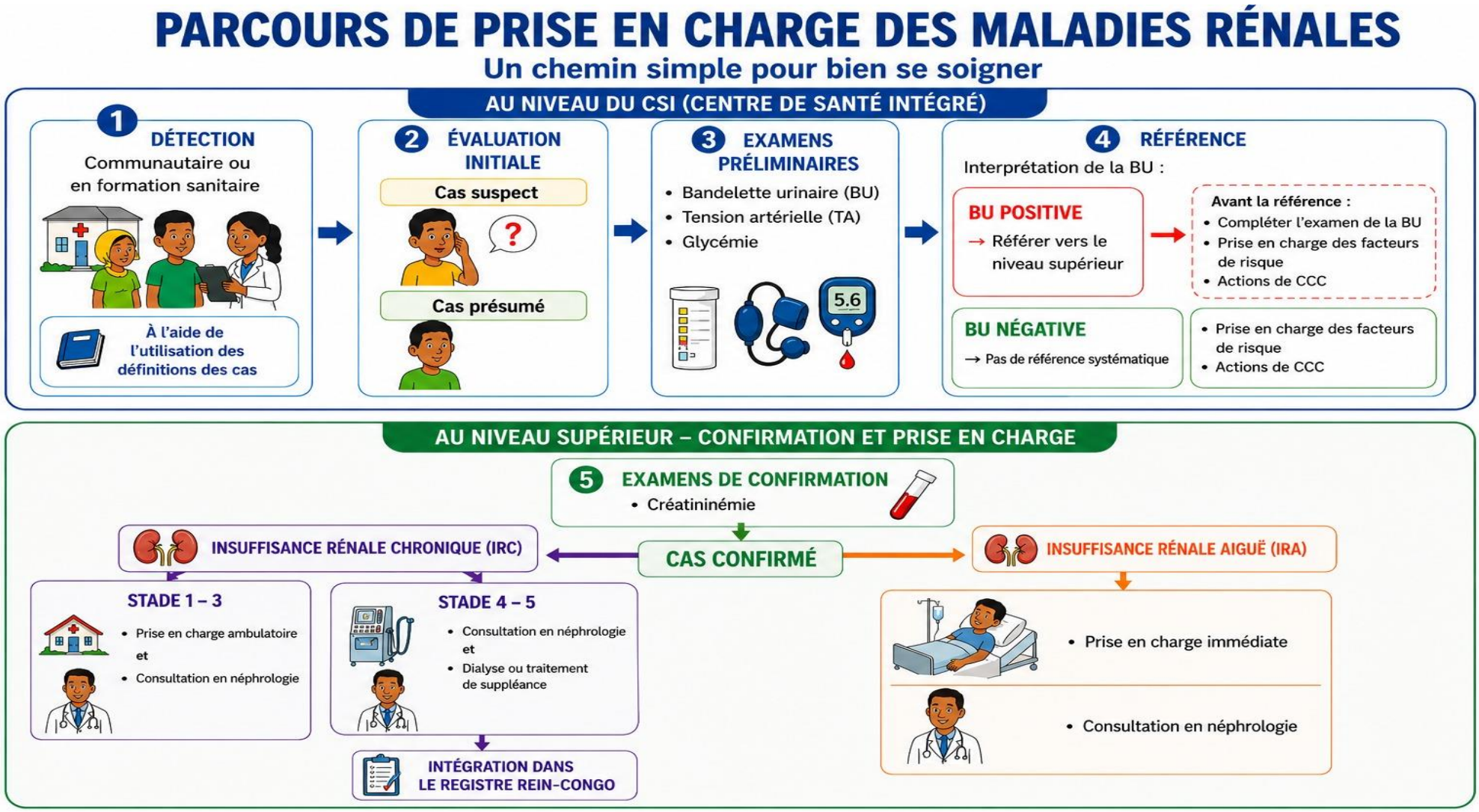
- Réception/enregistrement de données dans un registre approprié ainsi que la fiche de notification.
- Saisie et apurement de données dans le DHIS2 ;
- Analyse des données en fonction du temps, du lieu et des caractéristiques individuelles avec toutes les parties prenantes (gestionnaire de données, chefs de service, majors, prestataires des soins, responsables des structures et/ou toute personne concernée dans la structure)

Le tableau ci-après présente les types, les objectifs, les outils et les méthodes d'analyse.

Tableau IV : Méthodes et présentation des résultats

Type d'analyse	Objectifs	Méthode	Présentation des résultats
Temps	Suivre la tendance de l'insuffisance rénale	Comparer le nombre de cas notifiés pendant la période en cours avec le nombre de cas notifiés sur une période antérieure (semaine, mois, saison ou année).	Présenter les totaux sous forme de tableau, graphique ou texte.
Lieu	Déterminer les zones avec une fréquence élevée des cas	Présenter les fréquences sous forme de carte détaillée.	Présenter les fréquences sous forme de carte.
Caractéristiques individuelles	Décrire les cas selon les caractéristiques socio-démographiques et les facteurs de risques	Distribuer les cas en fonction des caractéristiques sociodémographiques et des facteurs de risque identifiés	Présenter les fréquences dans des tableaux, histogrammes**.**

Partie II : Gestion clinique et riposte



Partie III : Suivi, évaluation et qualité

III.1. Monitoring de la Surveillance

Le monitoring de la surveillance est un processus continu qui permet de s'assurer que le système fonctionne comme prévu et d'identifier rapidement les goulots d'étranglement. Il ne s'agit pas d'évaluer la santé des patients, mais la santé du système de surveillance lui-même. Ce suivi repose sur l'analyse régulière des rapports transmis via le DHIS2 et permet de s'assurer que chaque niveau de la pyramide sanitaire remplit ses obligations de notification.

Le monitoring inclut également le suivi de la disponibilité des outils de collecte, de la connectivité internet, du respect du circuit de transmission des données ainsi que de la régularité des réunions de revue des données. Il doit être réalisé de manière hebdomadaire au niveau opérationnel et mensuelle aux niveaux intermédiaire et central.

III.1.1. Indicateurs de performance du système de surveillance

La performance du système de surveillance est mesurée principalement par deux indicateurs clés : la complétude et la promptitude des rapports. La complétude évalue si toutes les formations sanitaires (FOSA) attendues ont effectivement transmis leur rapport mensuel, garantissant ainsi que les données nationales sont représentatives. La promptitude, quant à elle, mesure si ces rapports ont été transmis dans les délais fixés par le Ministère de la Santé (généralement au plus tard le 5 du mois suivant). Un système de surveillance performant doit viser un taux de complétude supérieur ou égal à 95% et de promptitude supérieure à 80 % pour garantir une prise de décision basée sur des informations à jour et exhaustives.

D'autres indicateurs peuvent également être suivis, notamment : le taux d'exhaustivité des variables renseignées, le pourcentage de rapports validés sans erreur, le taux de concordance entre les registres et les rapports transmis, ainsi que le délai moyen de correction des données erronées. Ces indicateurs permettent d'évaluer non seulement la transmission des données, mais également leur fiabilité et leur qualité. Les résultats des indicateurs doivent être analysés régulièrement lors des réunions de coordination afin de définir des actions correctrices adaptées.

III.1.2. Supervision formative des agents de santé

La supervision formative constitue l'outil de renforcement des capacités par excellence. Contrairement à une inspection classique, elle vise à accompagner les agents de santé dans leurs tâches quotidiennes. Lors des visites sur le terrain, les superviseurs du PNLIR ou du District Sanitaire vérifient la tenue des registres, aident à corriger les erreurs de remplissage des fiches de notification et s'assurent que les définitions de cas sont bien comprises et appliquées. Cette approche permet de résoudre les problèmes techniques sur place, de motiver le personnel et de garantir que les outils de collecte sont utilisés de manière optimale. Les superviseurs s'assurent également de la disponibilité et de l'utilisation correcte du matériel de dépistage et de prise en charge.

La supervision formative doit être planifiée à l'aide d'un calendrier annuel et réalisée à l'aide de check-lists standardisées. Chaque mission de supervision doit donner lieu à un rapport contenant les constats, les insuffisances observées, les recommandations formulées ainsi qu'un plan de suivi des actions correctives. Il est également recommandé d'organiser des séances de recyclage périodiques pour renforcer les compétences des agents sur les procédures de notification et d'utilisation du DHIS2.

III.2. Gestion de la Qualité des Données

La qualité des données est indispensable pour la crédibilité du système de surveillance. Une donnée de mauvaise qualité (incohérente, mal renseignée, manquante) conduit inévitablement à des décisions sanitaires erronées. La gestion de cette qualité repose sur la rigueur de chaque acteur de la chaîne, de l'agent qui remplit le registre au gestionnaire qui valide le rapport final.

Les dimensions essentielles de la qualité des données comprennent l'exactitude, la complétude, la cohérence, la fiabilité, la disponibilité et la ponctualité. Chaque niveau de la pyramide sanitaire doit mettre en œuvre des mécanismes internes de contrôle qualité afin de détecter rapidement les erreurs et d'assurer la traçabilité des corrections effectuées.

III.2.1. Procédures de validation et de nettoyage des bases de données.

Pour garantir l'exactitude des informations, des procédures strictes de validation sont mises en place à chaque niveau. Avant la saisie dans le DHIS2, les responsables des FOSA doivent effectuer une vérification de cohérence entre les registres de consultation et les fiches de

notification. Au niveau du District, le gestionnaire de données procède à la triangulation des données en identifiant les doublons, les valeurs aberrantes ou les données manquantes.

Ce travail de nettoyage permet d'épurer les données et de s'assurer que les analyses épidémiologiques reposent sur des faits réels et vérifiés. Avant la saisie définitive, les données sont validées au cours de la réunion mensuelle de validation des données du district sanitaire.

Des règles automatiques de validation sont configurées dans le DHIS2 afin de signaler les incohérences lors de la saisie des données. Les données suspectes doivent être retournées à la structure émettrice pour vérification et correction avant validation finale. Une sauvegarde régulière des bases de données ainsi qu'un archivage sécurisé des rapports physiques et électroniques doivent être assurés afin de prévenir toute perte d'information.

III.2.2. Retour d'information vers les districts et les structures de soins.

Le retour d'information, ou rétro-information, est le moteur de la motivation des agents de terrain. Il consiste à renvoyer régulièrement aux districts et aux FOSA une synthèse des données qu'ils ont collectées, accompagnée d'une analyse comparative (par rapport aux autres districts ou aux mois précédents). Ce mécanisme permet aux prestataires de soins de voir l'utilité de leur travail de collecte et de comprendre l'évolution de la situation de l'insuffisance rénale dans leur propre zone. Ce retour peut prendre la forme de bulletins épidémiologiques trimestriels, de réunions de coordination ou de tableaux de bord digitaux accessibles sur le DHIS2.

La retro-information est faite à tous les niveaux de la pyramide sanitaire :

- Du programme / DGSSSa vers les DDSSSa ;
- Des départements vers les districts sanitaires ;
- Des districts sanitaires vers les formations sanitaires.

Le retour d'information doit être régulier, structuré et orienté vers l'amélioration des performances. Il doit inclure les forces observées, les insuffisances identifiées, les tendances épidémiologiques majeures ainsi que les recommandations spécifiques pour chaque district ou structure de soins. Les tableaux de bord produits doivent être simples, compréhensibles et accessibles aux utilisateurs afin de favoriser l'utilisation des données pour la prise de décision locale. Il est également recommandé d'encourager les échanges d'expériences entre districts afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de surveillance épidémiologique.

III.3. Indicateurs

Ces indicateurs sont obtenus à partir des données recueillies à tous les niveaux du système de soins, d'autres informations seront recueillies à l'issue des campagnes, des enquêtes, des recherches et des données existantes dans le DHIS2.

Tableau V : Indicateurs

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
Taux de dépistage des maladies rénales	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de personnes dépistées de la maladie rénale	Nombre total de la population consultée	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle
Proportion des personnes dépistées positives (Cas présumés : marqueurs albuminurie, hématurie et créatinémie)	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de personnes dépistées positives (nombre de cas présumés)	Nombre total des personnes dépistées	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle
Proportion des personnes dépistées positives et orientées vers une prise en charge	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de personnes dépistées positives et orientées	Nombre de personnes dépistées positives	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
Taux d'accessibilité à l'hémodialyse	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de IRC-T diagnostiqués et mis en dialyse	Nombre total des IRC-T diagnostiqués	Centres spécialisés et HG	Registres	Mensuelle
Incidence HTA	$\frac{N}{D}$ x 1 000	Nouveaux cas d'HTA	Nombre total de la population à risque	À tous les niveaux	Registres	Annuelle
Proportion des patients hypertendus ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients hypertendus ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	Nombre total des patients hypertendus	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle
Incidence du Diabète sucré	$\frac{N}{D}$ x 1 000	Nouveau cas de diabète sucré	Nombre total de la population à risque	À tous les niveaux	Registres	Annuelle
Proportion des patients diabétiques ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients diabétiques ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	Nombre total des patients diabétiques	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
Proportion des patients VIH ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients VIH ayant effectué le dépistage de la maladie rénale	Nombre total des patients VIH	À tous les niveaux	Registres	Mensuelle
Prévalence de l'automédication dans les structures de santé	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de personnes automédiquées	Nombre total de la population consultée	À tous les niveaux	Rapport d'enquête	_
Prévalence de l'HTA	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre des personnes ayant l'HTA	Nombre total de la population	À tous les niveaux	Registres	Annuelle
Prévalence du diabète sucré	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de personnes ayant le diabète sucré	Nombre total de la population	À tous les niveaux	Registres	Annuelle
Nombre des patients en hémodialyse chronique de la période	Nombre	_	_	Centres spécialisés	Registres	Mensuelle

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
Incidence de l'IRA	$\frac{N}{D}$ x 1 000	Nouveaux cas d'IRA détectés	Nombre total de la population consultée	Les hôpitaux de base, généraux et centres spécialisées	Registres	Annuelle
Incidence de l'IRC	$\frac{N}{D}$ x 1 000	Nombre de nouveaux cas de l'IRC diagnostiqués (dans l'ensemble de la population)	Nombre total de la population à risque	Les hôpitaux de base, généraux et centres spécialisées	Registres	Annuelle
Prévalence de l'IRC	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients vivants avec une IRC connue	Nombre total de la population	Les hôpitaux de base, généraux et centres spécialisées	Registres	Annuelle
Proportion de la mortalité hospitalière imputée à l'IR	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de décès liés à l'IR en milieu hospitalier	Nombre total de décès hospitalier	Les hôpitaux de base, généraux et centres spécialisées	Registres	Mensuelle
Taux de mortalité des IR	$\frac{N}{D}$ x 1 000	Nombre de décès dû à l'IR	Population totale	Les hôpitaux de base, généraux et centres spécialisées	Registres	Annuelle

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
Proportion des patients décédés sous hémodialyse chronique	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients sous hémodialyse chronique décédés	Nombre total de patients sous hémodialyse chronique	Centres spécialisés	Registres	Mensuelle
Létalité des maladies rénales	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients décédés des maladies rénales	Nombre total des sujets malades	HB/HG et centres spécialisés	Registres	Annuelle
Nombre de cas suspects orientés	Nombre	_	_	Communautaire	Fiche de référence	Mensuelle
Nombre de cas suspects orientés et reçus au centre	Nombre	_	_	Communautaire et CSI	Fiche de référence/Registres	Mensuelle
Nombre de cas de perdu(e) de vue en dialyse de la période	Nombre	_	_	Centres spécialisées et Hôpitaux généraux	Registres	Mensuelle
Nombre de cas de perdu(e) de vue non dialysée de la période	Nombre	_	_	Centres spécialisées et Hôpitaux généraux	Registres	Trimestrielle
Nombre de personnes sensibilisées dans la	Nombre	_	_	Communautaire	Fiche de référence	Mensuelle

Indicateurs de santé	Mode de calcul	Numérateur (N)	Dénominateur (D)	Structure	Outils de collecte	Fréquence
communauté						
Proportion des patients diabétiques ayant développé une IR	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients diabétiques ayant développé une IR	Nombre de patients diabétiques	Centres spécialisées et Hôpitaux généraux	Registres	Mensuelle
Proportion des patients hypertendus ayant développé une IR	$\frac{N}{D}$ x 100	Nombre de patients hypertendus ayant développé une IR	Nombre de patients hypertendus	Centres spécialisées et Hôpitaux généraux	Registres	Mensuelle

Conclusion

La mise en place de ce guide national de surveillance épidémiologique est une étape décisive pour la santé publique en République du Congo. En harmonisant les définitions de cas et en intégrant la remontée des données dans la plateforme DHIS2, cet outil permet enfin de mesurer l'ampleur réelle de la maladie rénale dans tous les départements.

L'objectif final est de passer d'une gestion basée sur des estimations à un système de suivi rigoureux et continu. La réussite de ce dispositif repose désormais sur l'implication de chaque acteur de la pyramide sanitaire : de l'agent de santé communautaire qui repère les premiers signes, au médecin spécialiste qui confirme le diagnostic.

En respectant les procédures de notification et de contrôle qualité décrites dans ce document, nous nous donnons les moyens de mieux planifier les ressources, d'améliorer la prise en charge des patients et, à terme, de réduire significativement la mortalité liée à l'insuffisance rénale dans notre pays.

Ce guide est désormais le référentiel pour transformer chaque information collectée sur le terrain en une action concrète pour la survie des malades.

Références

1. World Health Organization. WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker programmes. Geneva: WHO; 2018.

2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024.

3. World Health Organization. Communicable disease surveillance and response systems. Geneva: WHO; 2006.

4. World Health Organization. Data collection and reporting tools for health systems strengthening. Geneva: WHO.

5. World Health Organization. Integrated Disease Surveillance and Response Technical Guidelines. 3rd ed. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa; 2019.

6. MedlinePlus. Creatinine Test. Bethesda; 2024.

7. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024.

8. World Health Organization. Screening programmes: a short guide. Geneva: WHO; 2020.

9. DHIS2. DHIS2 Documentation. University of Oslo; 2024.

10. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes. Diabetes Care. 2025.

11. World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneva: WHO; 2021.

12. Ministère de la Santé et de la Population. Normes des formations sanitaires. Brazzaville ; Congo.

13. National Kidney Foundation. Clinical Practice Guidelines. New York; 2023.

14. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Dialysis and Kidney Replacement Therapy Guidelines. 2024.

15. European Society of Cardiology. Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2024.

16. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. Geneva: World Health Organization; 2021.

17. European Society of Cardiology, European Society of Hypertension. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024.

18. World Health Organization. Hypertension Fact Sheet. Geneva; 2025.

19. World Health Organization. Noncommunicable Diseases. Geneva; 2025.

20. World Health Organization. Consolidated guidelines on person-centred HIV patient monitoring and case surveillance. Geneva; 2022.

21. World Health Organization. Public Health and Prevention Glossary. Geneva; 2021.

22. World Health Organization. Quality of Care Framework. Geneva; 2023.

23. World Health Organization Regional Office for Africa. Integrated Disease Surveillance and Response Technical Guidelines. 3rd ed. Brazzaville; 2019.

24. Centers for Disease Control and Prevention. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. 3rd ed. Atlanta; 2012.

25. World Health Organization. Health Information Systems Toolkit. Geneva; 2023

26. International Society of Nephrology. Global Kidney Health Atlas, 2023.

27. World Health Organization. Global Health Estimates / Noncommunicable Diseases Reports, 2024.

28. World Health Organization Regional Office for Africa. Integrated Disease Surveillance and Response Guidelines, 2019–2022.

29. Étude CHU de Brazzaville, service de néphrologie (article scientifique / revue indexée sur la maladie rénale chronique au Congo).

V. Annexes techniques

1. **Fiches Standardisées :**

    - Annexe 1 : Fiche de collecte des agents communautaires.

Désignation	**Moins de 15 ans**		**15-24 ans**		**25-44 ans**		**45-54 ans**		**55-64 ans**		**65 ans et +**		**Total**	
	M	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Nombre de personnes sensibilisées à l'IR														
Nombre de cas suspects d'IR identifiés														
Nombre de cas suspects orientés vers le CSI														
Nombre de cas suspects reçus au CSI (retour d'information)														

Annexe 2 : Fiche de collecte des formations sanitaires.

Indicateur	0-28 j		29j-11 mois		1-4 ans		5-14 ans		15-24 ans		25-64 ans		65 ans et +		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nombre de cas dépistés par bandelette urinaire																
Nombre de cas avec protéinurie positive																
Nombre de cas avec hématurie positive																
Nombre de cas avec HTA connue + bandelette positive																
Nombre de cas avec diabète + bandelette positive																
Nombre de cas d'automédication (AINS, antibiotiques, antipaludéens, …) + bandelette positive																
Nombre de cas avec créatininémie élevée (si possible)																
Nombre de cas référé à l'hôpital																

- Annexe 3 : Fiches de collecte des hôpitaux et centres spécialisés.

Prise en charge des cas d'insuffisance rénale

Indicateur		0-28 j		29j-11 mois		1-4 ans		5-14 ans		15-24 ans		25-64 ans		65 ans et +		Total	
		M	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Nombre de cas d'IRC par stade	**1**																
	2																
	3																
	4																
	5																
Nombre de cas d'IRC tout stades confondus																	
Nombre de cas d'IRC dialysés																	
Nombre de cas d'insuffisance rénale aiguë (IRA)																	
Nombre de cas d'IRA dialysés																	
Nombre de cas de IRC ou IRA référés à un niveau supérieur																	

Prise en charge par dialyse

Indicateur		0-28 j		29j-11 mois		1-4 ans		5-14 ans		15-24 ans		25-64 ans		65 ans et +		Total	
		M	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Nombre total de patients dialysés (anciens + nouveaux)																	
Nombre de nouveaux patients dialysés dans le mois																	
Nombre de patients hémodialysés avec fistule artérioveineuse fonctionnelle																	
Nombre de patients hémodialysés par cathéter temporaire																	
Nombre de patients hémodialysés par cathéter permanent																	
Nombre de patients ayant effectué une dialyse péritonéale																	
Nombre de séances d'hémodialyse réalisées dans le mois																	
Nombre de dialysés porteurs d'une hépatite B ou C																	
Nombre de patients perdus de vue en dialyse																	
Fréquence hebdomadaire	1																
	2																
	3																

Décès liés à l'insuffisance rénale

Indicateur	0-28 j		29j-11 mois		1-4 ans		5-14 ans		15-24 ans		25-64 ans		65 ans et +		Total	
	M	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Nombre de décès liés à l'IRC																
Nombre de décès liés à l'IRA																
Nombre de décès chez les dialysés																

Facteurs de risque et comorbidités associées à l'IR

Pathologie	0-28 j		29j-11 mois		1-4 ans		5-14 ans		15-24 ans		25-64 ans		65+		Total	
	M	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
HTA connue																
Diabète sucré																
Drépanocytose																
Lupus / maladie auto-immune																
Infection urinaire à répétition																
Automédication (AINS, antibiotiques, …)																
Polykystose rénale																
Phytothérapie																
Maladie obstructive																

2. **Aides à la décision (Job Aïds) :**

   - Annexe 3 : Protocole de dépistage par bandelette urinaire.

